

ESTRIDOR — CRUPE vs EPIGLOTITE vs CE

CAUSAS DE ESTRIDOR AGUDO — DIFERENCIAÇÃO

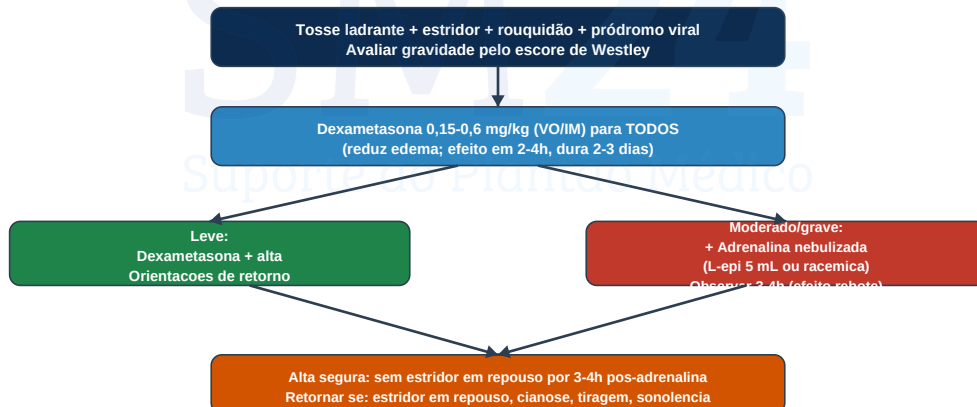
Causa	Idade	Clínica	Conduta chave
Crupe viral (laringotraqueíte)	6m-3a	Tosse ladrante, estridor, rouquidão, febre baixa, pródromo viral	Corticoide + nebulização adrenalina
Epiglotite	2-7a	Toxemia, sialorreia, posição tripé, disfagia, SEM tosse, febre alta	NAO examinar garganta! Via aérea no CC
Traqueíte bacteriana	3-10a	Toxemia + estridor + secreção purulenta + febre alta	ATB IV + via aérea
Corpo estranho	1-3a	Início SÚBITO, engasgo, sem pródromo, assimetria à ausculta	Broncoscopia
Abscesso retrofaríngeo	<6a	Disfagia, rigidez de nuca, abaulamento de parede posterior	TC + drenagem + ATB
Anafilaxia/angioedema	Qualquer	Início rápido, urticária, exposição a alérgeno	Adrenalina IM

CRUPE — ESCORE DE WESTLEY E TRATAMENTO

Gravidade	Características	Tratamento
Leve (Westley <=2)	Tosse ladrante, sem estridor em repouso, sem tiragem	Dexametasona 0,15-0,6 mg/kg VO dose única + alta
Moderada (3-7)	Estridor em repouso + tiragem leve-moderada	Dexametasona + nebulização com adrenalina + observação 3-4h
Grave (>=8)	Estridor em repouso + tiragem grave + agitação/letargia	Adrenalina nebulizada + dexametasona + O2 + considerar UTI
Iminência de fálência	Cianose, sonolência, redução do estridor (mau sinal!)	Via aérea avançada (IOT) + UTI

MANEJO DO CRUPE

CRUPE — CORTICOIDE PARA TODOS



EPIGLOTITE — EMERGÊNCIA DE VIA AÉREA

NAO EXAMINAR A GARGANTA — RISCO DE OBSTRUÇÃO TOTAL

- Criança toxemiada, posição de tripé, sialorreia (não engole), SEM tosse, voz abafada
- Causa: H. influenzae tipo B (HiB) — raro pós-vacina; considerar em não vacinados
- NAO usar abaixador de língua, NAO deitar a criança, NAO causar ansiedade — risco de laringoespasmo fatal
- Manter a criança calma no colo dos pais; oferecer O2 sem incomodar
- Via aérea definitiva no centro cirúrgico (anestesia + ORL) — IOT eletiva com equipe preparada
- Após via aérea segura: ATB IV (ceftriaxona) + UTI

ADRENALINA E CORTICOIDE NO CRUPE

Adrenalina Nebulizada

- L-adrenalina 1:1000: 0,5 mL/kg (máx 5 mL) nebulizada
- Adrenalina racêmica 2,25%: 0,5 mL em 3 mL de SF
- Início rápido (10-30 min); efeito dura 2 horas
- Efeito rebote: observar 3-4h após (edema pode retornar)
- Indicação: crupe moderado-grave com estridor em repouso
- Não alterar o curso da doença — apenas alívio temporário

Dexametasona

- Dose: 0,15-0,6 mg/kg VO/IM dose única (máx 16 mg)
- Indicada em TODOS os graus de crupe (mesmo leve)
- Reduz edema subglótico; efeito em 2-4h, dura 2-3 dias
- VO tão eficaz quanto IM; budesonida inalada é alternativa
- Reduz retornos, internações e necessidade de adrenalina
- Dose única geralmente suficiente (meia-vida longa)

SINAIS DE ALARME — VIA AÉREA

INTERNAR / UTI SE...

- ☐ Estridor em repouso persistente após adrenalina
- ☐ Tiragem grave (intercostal, subdiafragmática, fúrcula)
- ☐ Cianose ou SpO2 <92% em ar ambiente
- ☐ Sonolência, agitação ou rebaixamento de consciência
- ☐ Redução paradoxal do estridor + piora do estado geral (obstrução iminente)
- ☐ Suspeita de epigloteite, traqueíte bacteriana ou corpo estranho

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Criança de 2 anos com tosse ladrante, estridor em repouso e tiragem moderada após pródrômo viral. Qual é o tratamento?

- A) Antibiótico oral e alta
- B) Dexametasona + nebulização com adrenalina + observação 3-4h
- C) Apenas nebulização com soro fisiológico
- D) Intubação imediata
- E) Broncoscopia para corpo estranho

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Criança de 4 anos, toxemiada, sentada inclinada para frente, com sialorreia e SEM tosse. Febre alta. Qual conduta é CONTRAINDICADA?

- A) Manter a criança calma no colo dos pais
- B) Oferecer oxigênio sem incomodar
- C) Examinar a orofaringe com abaixador de língua
- D) Acionar anestesia e ORL para via aérea no centro cirúrgico
- E) Administrar oxigênio suplementar

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é a conduta medicamentosa indicada para TODOS os graus de crupe, mesmo os leves?

- A) Adrenalina nebulizada
- B) Dexametasona (corticoide) dose única
- C) Antibiótico oral
- D) Broncodilatador beta-2
- E) Anti-histamínico

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Após nebulização com adrenalina em crupe moderado, por que a criança deve ser observada por 3-4 horas antes da alta?

- A) Porque a adrenalina causa taquicardia que precisa ser monitorada
- B) Porque o efeito da adrenalina é temporário (~2h) e pode haver efeito rebote do edema
- C) Porque a dexametasona ainda não fez efeito
- D) Porque é necessário aguardar exames de imagem
- E) Porque a criança precisa de antibiótico IV antes da alta

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Lactente de 18 meses, previamente hígido, apresenta início SÚBITO de estridor e tosse após episódio de engasgo enquanto brincava. Sem febre. Qual é a principal hipótese?

- A) Crupe viral
- B) Epiglotite
- C) Aspiração de corpo estranho
- D) Bronquiolite
- E) Asma

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Crupe moderado (estridor em repouso + tiragem moderada): dexametasona (para todos os graus) + nebulização com adrenalina (alívio do edema subglótico) + observação 3-4h pelo efeito rebote da adrenalina. Alta se sem estridor em repouso após observação.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Quadro clássico de epiglotite: toxemia, posição de tripé, sialorreia, sem tosse. EXAMINAR A GARGANTA com abaixador é CONTRAINDICADO — pode desencadear laringoespasma e obstrução total fatal. Manter a criança calma, O2, via aérea no centro cirúrgico com equipe preparada.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Dexametasona (0,15-0,6 mg/kg dose única) é indicada para TODOS os graus de crupe, incluindo os leves. Reduz edema subglótico, retornos, internações e uso de adrenalina. Adrenalina nebulizada fica reservada para crupe moderado-grave (estridor em repouso).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Adrenalina nebulizada tem início rápido (10-30 min) mas efeito curto (~2h). Após esse período, o edema pode retornar (efeito rebote). Por isso a observação de 3-4h é necessária antes da alta, garantindo que a dexametasona já fez efeito e não há recorrência do estridor em repouso.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Aspiração de corpo estranho: início SÚBITO de estridor/tosse + história de engasgo durante brincadeira/alimentação + ausência de febre e pródromo viral, em lactente. Diferente do crupe (gradual, pródromo viral). Conduta: broncoscopia rígida para remoção.

SM24
Suporte ao Plantão Médico